

Infections respiratoires basses

Evaluation pour ENC année 2023

Dr Rahma Gargouri

6-8-25

Les propositions correctes concernant la bronchite aiguë

- a. L'hyperréactivité bronchique peut durer 4 semaines
- b. L'origine est virale dans 50% des cas
- c. Elle survient par épidémies
- d. Elle menace le pronostic vital
- e. Elle est fréquente chez l'adulte jeune

ace

A propos de la bronchite aiguë

- a) La cause bactérienne est estimée à 10% des cas
- b) La bactérie la plus incriminée est le staphylocoque auréus
- c) La cause peut-être virale avec une surinfection bactérienne
- d) La couleur jaune des expectorations est toujours synonyme de cause bactérienne
- e) Une origine virale est probable devant les céphalées et les myalgies

Dans la bronchite aiguë

- a) La fièvre est en plateau à 40°C
- b) La toux est pénible dans les premières 48h
- c) La douleur thoracique est typiquement latéralisée aux bases
- d) L'état neurologique est altéré
- e) Des signes d'imprégnation tuberculeuse sont possibles

b

Les propositions correctes à propos de la bronchite aiguë sont:

- a) La fièvre est à recrudescence nocturne
- b) La dyspnée est habituelle
- c) Une phase d'expectorations facile survient après quelques jours
- d) Un larmoiement est fréquent
- e) Une dissociaction pouls température est classique

La bronchite aiguë bactérienne est

- A. Secondaire à des germes atypiques dans certains cas
- B. Survient par épidémie
- C. Se poursuit par une hyper-réactivité bronchique en faveur de l'asthme
- D. La purulence des expectorations fait évoquer les pyogènes
- E. L'HI est un germe de surinfection d'une cause virale en cas de BPCO

abde

Signes suggestifs de bronchite	Signes suggestifs de pneumonie
- Fièvre en général peu élevée - Brûlure rétrosternale - Toux parfois précédée d'infections des voies respiratoires hautes - Auscultation normale ou râles bronchiques diffus	- Fièvre > 3,8°C - Tachycardie > 100/min - Polypnée > 25/min - Douleur thoracique - Absence d'infection des voies respiratoires hautes - Signes auscultatoires en foyer (râles crépitants) - Impression globale de gravité

Une bronchite aiguë virale peut se compliquer de

- a) Pneumopathie interstitielle diffuse
- b) Vomissement
- c) Dilatation des bronches
- d) Etat de choc septique
- e) Pleurésie purulente

b

Les traitements de première intention pour une bronchite virale simple chez un sujet jeune sont

- A. Levofloxacin
- B. Corticothérapie injectable
- C. Nébulisation de bronchodilatateurs
- D. Théophylline
- E. Hydratation orale optimale

e

Une pneumonie

- a) Est une urgence diagnostique et thérapeutique
- b) Peut se compliquer de pleurésie
- c) répétée dans le même lobe, elle doit faire craindre une néoplasie
- d) Est due le plus fréquemment à un virus
- e) Est moins fréquente chez les tabagiques

abc

En cas de pneumonie alvéolaire

- a) L'infection se propage de proche en proche par les pores inter-alvéolaires
- b) L'atteinte traverse les scissures
- c) Les espaces alvéolaires distaux sont détruits
- d) Les bronchioles sont touchées
- e) Les espaces aériens distaux sont comblés de matériel amorphe



a

En cas de pneumonie franche lobaire aiguë

- a) Une douleur thoracique retrosternale est classique
- b) Un herpès naso-labial fait évoquer l'origine virale
- c) Une altération brutale de l'état général est possible
- d) Une hématurie fait évoquer la légionnellose
- e) Une douleur articulaire est possible

cde

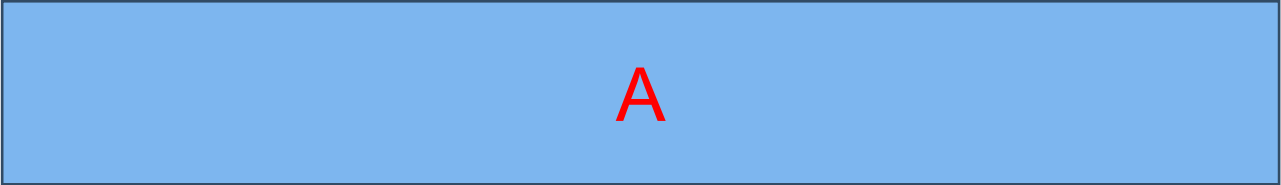
L'examen physique montre en cas de pneumonie franche lobaire aiguë

- a) Une fièvre atteignant un plateau supérieur à 38°C
- b) Des vibrations vocales abolies
- c) Un syndrome pleural liquidien
- d) Des rales crépitants en couronne
- e) Un souffle tubaire

ade

En cas de suspicion clinique de pneumonie alvéolaire chez un sujet sain, l'examen complémentaire de première intention est:

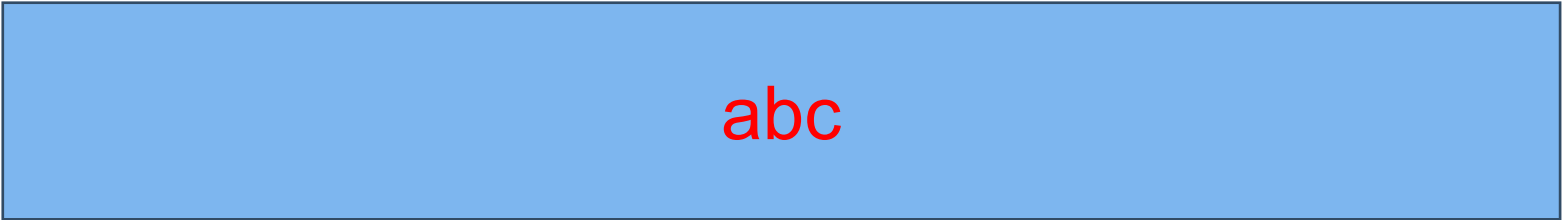
- a. Radiographie thoracique standard
- b. Echographie thoracique
- c. Sérologie des atypiques
- d. RT-PCR COVID 19
- e. Scanner thoracique



A

Les éléments de gravité d'une pneumonie chez un malade sont

- a) Confusion
- b) Neutropénie
- c) Deshydratation
- d) $PO_2 < 80$ mmHg
- e) Matité suspendue à la percussion



abc

Critères du score CRB 65	Conduite à tenir
C : Confusion R : Fréquence respiratoire ≥ 30 / mn B : Pression artérielle systolique < 90 mmHg ou Pression artérielle diastolique ≤ 60 mmHg 65 : Age* ≥ 65 ans	0 critère : traitement ambulatoire possible ≥ 1 critère : évaluation à l'hôpital
C pour confusion, R pour respiratoire, B pour blood pressure et 65 pour 65 ans.	
* Plus que l'âge civil, l'âge physiologique - notamment chez les patients sans co-morbidité - est à prendre en compte	

Score CRB65

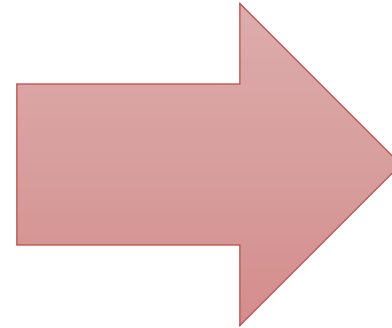
Simple à utiliser en situation d'urgence

C: Confusion

R: Fréquence respiratoire $> 30/\text{min}$

B: PAS < 90 mm Hg ou PAD ≤ 60 mm Hg

65: Age ≥ 65 ans



0 critère :

traitement
ambulatoire
possible

≥ 1 critère :

évaluation à
l'hôpital

Score de FINE

Score de Fine			
Critères	Points	Critères	Points
Age		Examen clinique	
Homme	Age	Tr. Conscience	+20
Femme	Age - 10	Polypnée > 30 /min	+20
Vie en communauté	+10	PAS < 90 mm Hg	+20
		Température > 40 ou < 35°C	+15
		Pouls > 125/min	+10
ATCD		Données paracliniques	
Neoplasie	+30	Ph < 7.35	+30
Path. Hépatique	+20	Urée > 0.3g/l	+20
Insuf. Cardiaque	+10	Na+ < 130mEq /l	+20
Path. Neurologique	+10	Glycémie > 2.5 g/l	+10
Path. Rénale	+10	Hématocrite < 30%	+10
		PaO2 < 60mmHg	+10
		Epanchement pleural	+10

Score prédictif de mortalité et d'hospitalisation en réanimation

CLASSE	I	II	III	IV	V
Points	-	70	71-90	91-130	> 130
Réanimation %	4,3	4,3	5,9	11,4	17,3
Mortalité %	0,1	0,6	0,9	9,3	27,0

Gravité clinique

- Troubles de conscience
- PAS < 90 mm hg
- Tachycardie > 125
- Polypnée > 30
- Cyanose
- Température < 35°C ou > 40°C.

Gravité biologique

- GB <4000 ou >30000
- Hb < 9g/dl
- Insuffisance rénale
- PaO₂ < 60mmHg, PaCO₂ > 50mmHg, pH<7,30
- Anomalies hémostase

Gravité de la
pneumonie
communautaire

Gravité radiologique

- Atteinte bi-lobaire
- Épanchement pleural
- Opacité excavée
- Extension rapide des lésions

Situation particulière

- Néoplasies associées
- Pneumonies d'inhalation ou sur obstacle trachéo-bronchique
- Localisations septiques associées: méningite...

Concernant la bronchopneumonie

- a) L'atteinte fongique concerne les bronchioles et les alvéoles
- b) C'est une forme grave et mortelle
- c) L'atteinte peut-être bilatérale
- d) Les complications pleurales sont fréquentes
- e) Elle peut causer une hypoxie

bcde

Les propositions correctes à propos de la bronchopneumonie sont

- a) Comporte des infiltrats hétérogènes mal limités à plus qu'un lobe
- b) Survient plus fréquemment chez le tabagique
- c) La présence d'un rayon de miel est classique
- d) Possibilité d'excavations
- e) La présence d'opacités spiculées multiples est en faveur du diagnostic

abd

Les propositions correctes à propos de la pneumonie atypique sont:

- a) L'atteinte infectieuse touche l'interstitium pulmonaire
- b) La pleurésie par-pneumonique est fréquente
- c) Un syndrome pseudogrippal est en faveur du diagnostic étiologique
- d) Une hyponatrémie est en faveur du diagnostic étiologique
- e) L'état général est classiquement altéré

acd

Les propositions correctes à propos de la pneumonie à *légionella pneumoniae* sont

- a) Survient par une épidémie de groupe
- b) Fait suite à une contamination sanguine
- c) La contamination est inter-humaine
- d) Les enfants sont plus exposés
- e) Elle est à déclaration obligatoire

ae

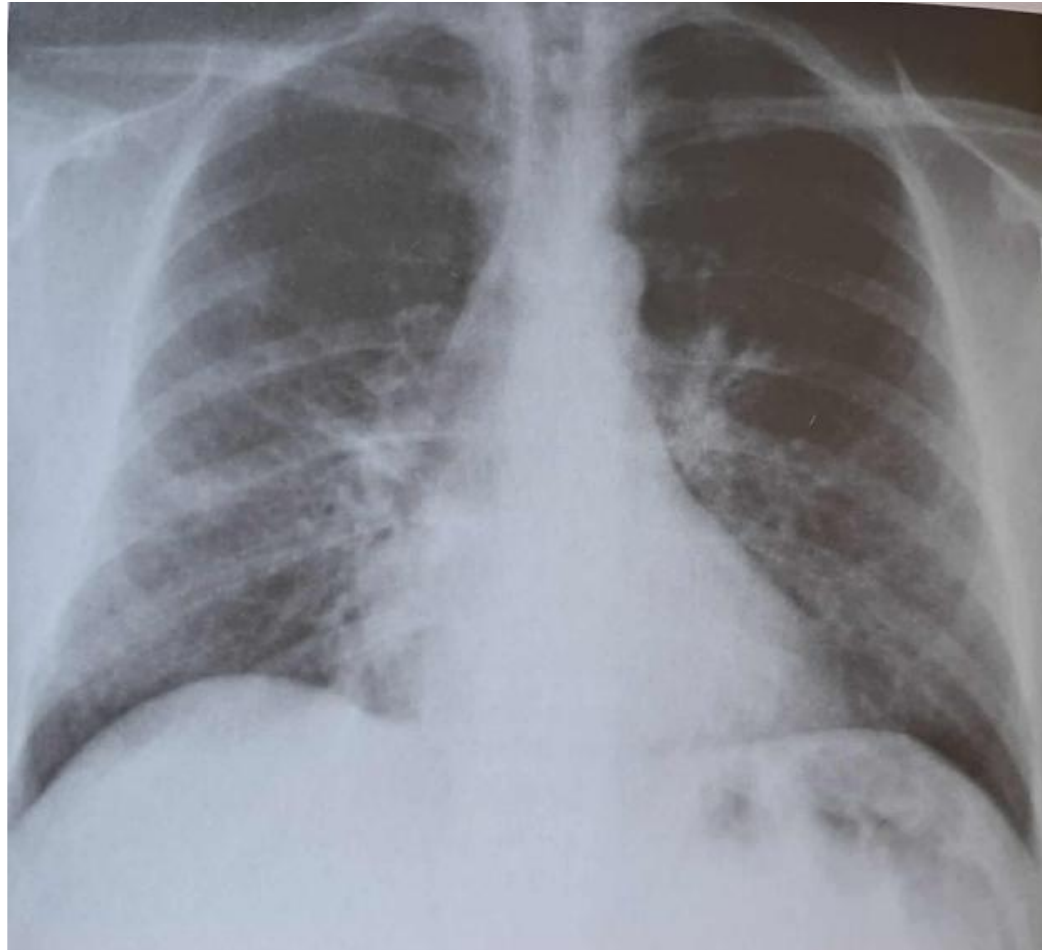
Concernant les germes en cause des pneumonies

- a) Le germe le plus incriminé dans les PFLA est l'*Hémophilus*
- b) L'infection à staphylocoque pneumonia est necrosante
- c) L'infection aux anaérobies survient en cas de trouble de la déglutition
- d) Les pneumopathies du sujet âgé sont souvent causées par des cocci gram +
- e) Le terrain du malade dicte l'antibiothérapie initialement probabiliste

bce

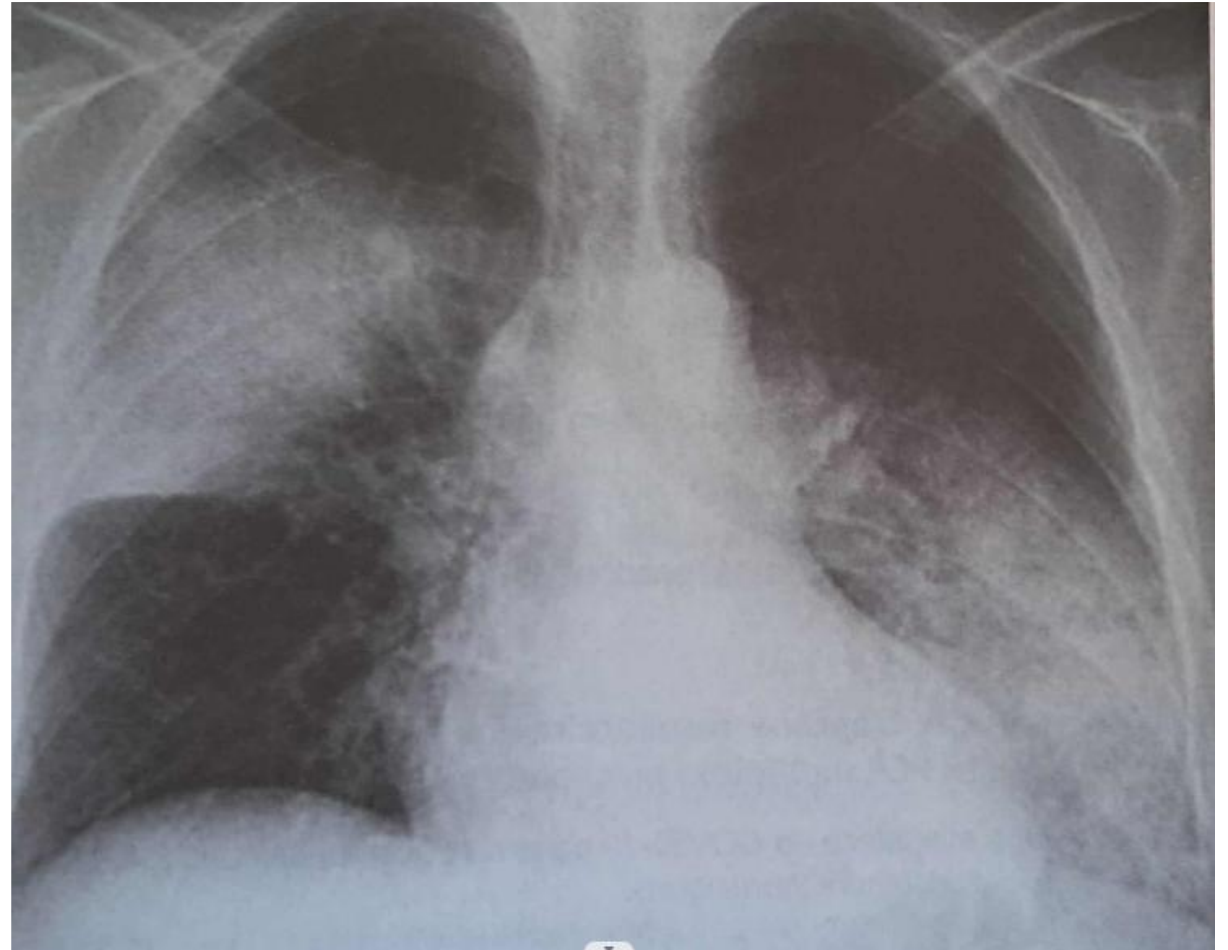
Pneumonie atypique

opacités hétérogènes, peu denses,
hilo_x0002_basales, non
systématisées ou diffuses aux deux
champs pulmonaires



Pneumonie à legionnelle

opacités alvéolaires non
systématisées, le plus souvent arrondies et
bilatérales.



Les propositions correctes à propos des germes des IRB sont

- A. La pneumonie à pneumocoque se complique de pleurésie para-pneumonique
- B. Mycoplasme est responsable de pneumonie alvéolaire grave
- C. HI peut donner des pneumonies interstitielles
- D. Klebsielle est pourvoyeuse de pyo-pneumothorax
- E. Klebsiella est responsable de bombement scissuraux

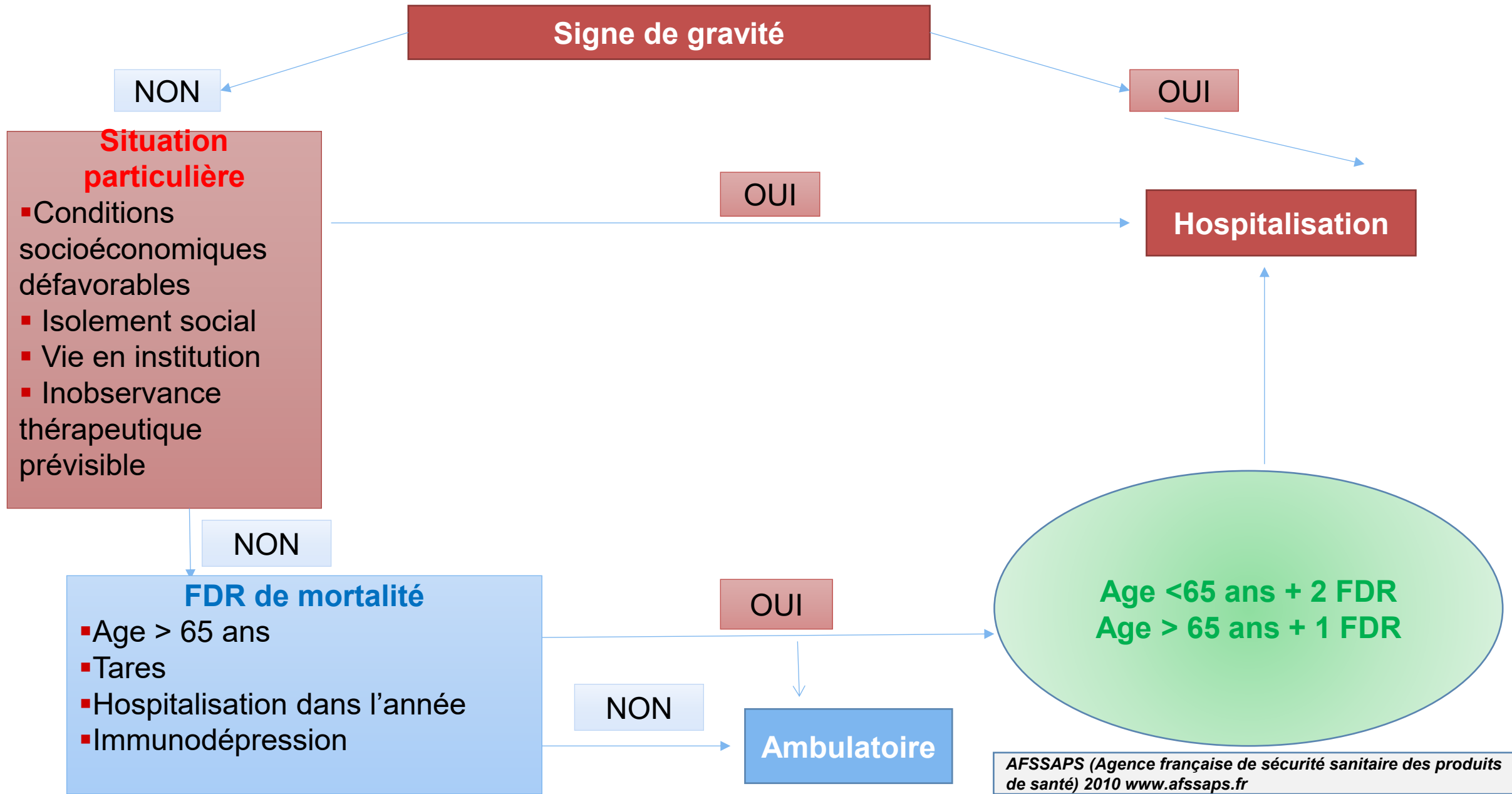
	Pneumocoque (PFLA)	Mycoplasme (atypique)	Légionellose
Fréquence	+++++	++	+
Contexte	Rarement de contexte particulier, mais plus fréquent si cirrhose, âge > 65 ans ou immunodéprimé (VIH++)	Contexte épidémique Adulte jeune	Contexte épidémique Situation à risque : voyage, thermes, exposition à l'eau ou aux aérosols contaminés Sujets âgés, comorbidités et immunodépression
Début	Brutal	Progressif (2-3 jours)	Rapidement progressif
Tableau clinique	Bruyant : T° élevée, malaise général	Peu bruyant, non grave	Bruyant, gravité Dissociation pouls-température
Signes thoraciques	OUI ++ : douleur thoracique, expectorations saumonées	Modérés (examen fréquemment normal, toux sèche)	Modérés
Signes extrathoraciques	RARES Récurrence possible d'herpès labial (en faveur d'une pneumococcie)	OUI + ORL (rhinopharyngite) Polyarthralgies, myalgies Diarrhées Éruption cutanée / muqueuses	OUI +++ (1/3 des cas) Pas de signes ORL Myalgies ++ Digestifs ++ : diarrhées, douleurs abdominales, vomissements Neurologiques + : confusion, hallucinations, bradycardie
Biologie (si réalisée)	Aspécifique (hyperleucocytose à PNN, procalcitonine élevée...)	Cytolyse hépatique Anémie hémolytique (agglutinines froides)	Cytolyse hépatique Insuffisance rénale Hyponatrémie Rhabdomyolyse (CPK élevées)
Microbiologie (si réalisée)	ECBC : CG+ en chaînettes (diplocoques) au direct antigénurie pneumocoque + HC surtout si forme grave	PCR sur prélèvement respiratoire (virage sérologique)	Antigénurie légionelle + Culture de sécrétion respiratoire sur milieu spécifique (à visée épidémiologique) PCR sur prélèvement respiratoire
RXT	Condensation systématisée	Opacités multifocales	Condensation systématisée ou opacités multifocales, bilatérales
Réponse aux bêtalactamines	OUI	NON	NON

Une pneumopathie ne doit jamais être traitée en ambulatoire si

- A. Le patient présente une mauvaise condition sociale
- B. La radiographie montre une réaction pleurale
- C. La CRP est positive
- D. La radiographie montre un foyer alvéolaire
- E. Le patient est âgé de plus de 70 ans

ab

Pneumonie communautaire



Les propositions correctes à propos de l'antibiothérapie au cours des pneumopathies infectieuses bactérienne

- a) Elle est urgente
- b) A une durée écourtée dans certains cas selon les nouvelles recommandations
- c) Le mycoplasme doit être couvert par l'antibiothérapie
- d) Une adaptation à 48h est possible en cas de mauvaise évolution
- e) Elle est choisie de première intention à la lumière de l'enquête bactériologique

Abd

Cochez les réponses correctes à propos de l'antibiothérapie en cas de pneumonie

- a) La pristinamycine est une alternative à la pénicilline en cas de PFLA
- b) En cas d'allergie aux betalactamines, la meilleure alternative est les macrolides
- c) L'amoxicilline-acide clavulanique couvre souvent les HI
- d) L'amoxicilline-acide clavulanique est actif sur tous les BGN
- e) Toutes les C3G ont une bonne diffusion pulmonaire

a,c

Quels sont les antibiotiques actifs sur les germes intracellulaires

- a. Ceftriaxone
- b. Erythromycine
- c. Amoxicilline
- d. Doxycycline
- e. Levofloxacin

B,d,e

Le choix de l'antibiothérapie en cas de pneumopathie

- a) Est d'abord probabiliste
- b) De première intention, elle n'est pas en fonction de la gravité clinique initiale
- c) N'est pas dépendante des antécédents infectieux du patient
- d) L'erythromycine est préconisée en cas de legionnelle non grave
- e) La meilleure indication des macrolides, est une suspicion d'infection à mycoplasmes

A, d e

Concernant une antibiothérapie ambulatoire en cas de PFLA non grave

- a. Le HI doit être visé car il est fréquent
- b. La possibilité d'un contrôle à 48-72 h doit être de règle
- c. En cas de mauvaise évolution sous amoxicilline, une PFLA peut être traitée par pristinamycine
- d. L'association amoxicilline+acide clavulanique est préconisé si sujet âgé
- e. La levofloxcine est réservée aux malades jeunes

b,c,d

PSDP++++

- l'âge > 65 ans
- prescription antérieure de β -lactamines dans les 3 mois
- une hospitalisation récente dans les 3 mois,
- maladie chronique (BPCO, cancer, VIH)
- l'acquisition nosocomiale de la pneumonie et les antécédents de pneumonie dans l'année.

de plus en plus résistant aux macrolides++++

En cas de pneumonie avec nécessité d'hospitalisation en milieu médical

- a) Pour les sujets âgés, on prescrit l'amoxicilline-acide clavulanique
- b) On prescrit une double antibiothérapie
- c) Pour les sujets âgés, on proscriit des macrolides
- d) L'amoxicilline peut être donnée si l'antigénurie pneumocoque est positive
- e) La pristinamycine n'est plus indiquée

A, d,

Tableau : Antibiothérapie des PAC en ambulatoire

Sujet sain sans signe de gravité	AMOXICILLINE <u>ou</u> MACROLIDE Pristinamycine (alternative) Pristinamycine (alternative)
si échec à 48-72 heures	switch
Sujet avec comorbidité ou Sujet âgé ambulatoire (hors institution)	Amoxicilline/acide clavulanique <u>ou</u> FQAP <u>ou</u> ceftriaxone
si échec à 48-72 heures	hospitalisation

Tableau : Antibiothérapie des PAC en hospitalisation conventionnelle

		1 ^{ère} choix	si échec à 48-72 h
Pneumocoque suspecté ou documenté ¹⁵	Tous âges	Amoxicilline	Réévaluation
Pas d'argument en faveur du pneumocoque	Sujet jeune	Amoxicilline Pristinamycine (alternative)	Association à un macrolide ou switch par FQAP (lévofloxacine) Réévaluation
	Sujet âgé (y compris en institution) ou avec comorbidité(s)	Amoxicilline/acide clavulanique <u>ou</u> FQAP <u>ou</u> ceftriaxone	Réévaluation